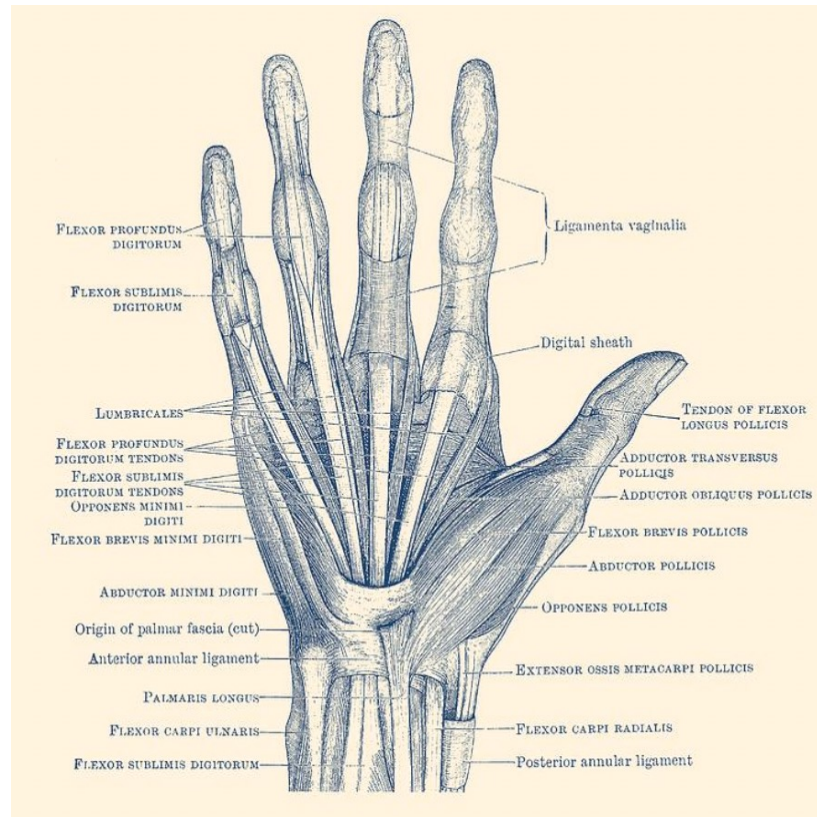


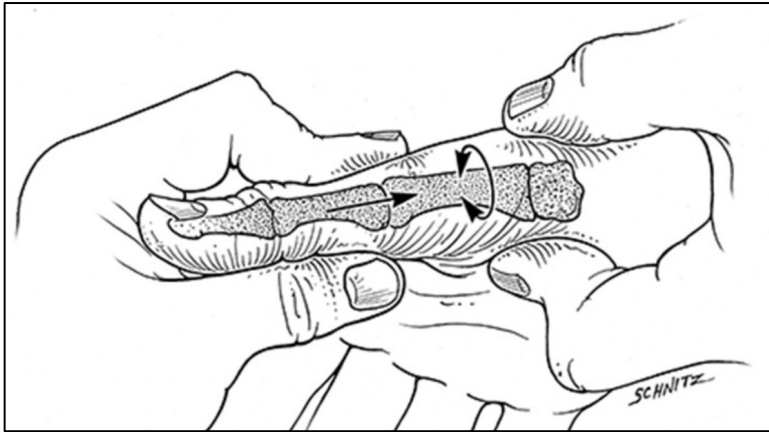
Poignet-main : Rappel des tests spécifiques et pathologies courantes



Poignet-main : Tests spécifiques

Rhizarthrose: Grinding test

- Mobilisation de l'articulation **trapezo-métacarpienne** (rotation interne, externe, pression) : positif si reproduit la douleur ou provoque des crépitations lors du frottement



Suspicion fracture du scaphoïde: Scaphoïd shift-test

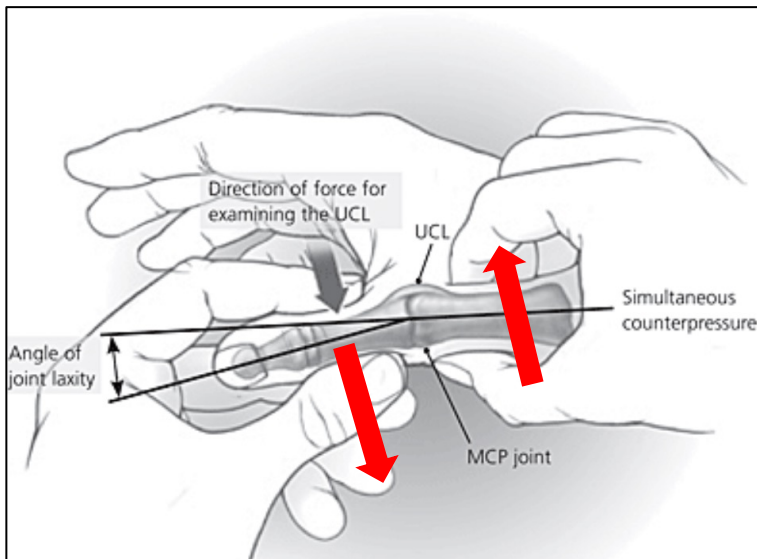
- Permet de mettre en évidence une lésion du **ligament scapho-lunaire**, le principal DD de la fracture du scaphoïde.
- L'examineur applique une pression au niveau de la face palmaire du scaphoïde et effectue une inclinaison radiale de la main. Si le test est négatif (pas de douleur) que la palpation de tabatière anatomique est douloureuse, il s'agit d'une fracture du scaphoïde jusqu'à preuve du contraire.



Poignet-main : Tests spécifiques

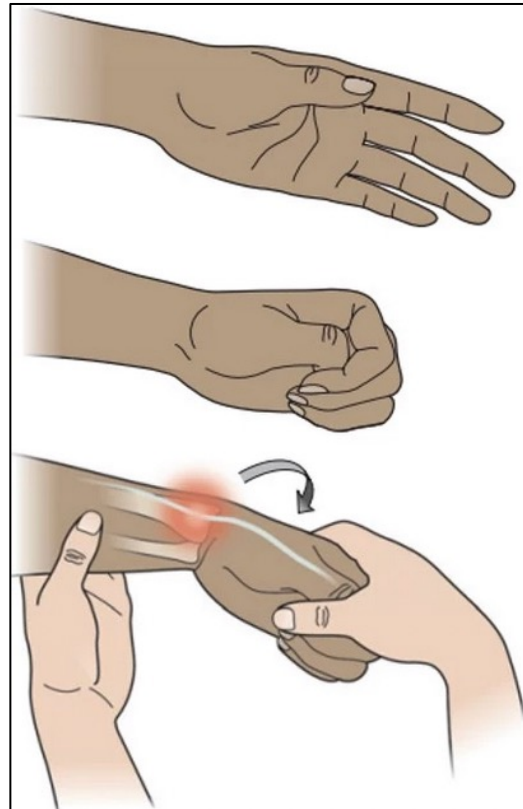
Pouce du skieur: Valgus stress

- Stress mécanique de ligament **métacarpo-phalangien** du pouce au moyen d'un stress en valgus



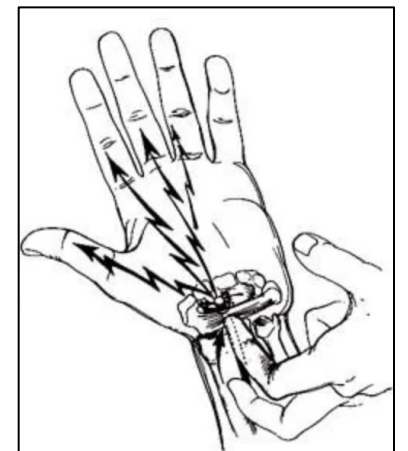
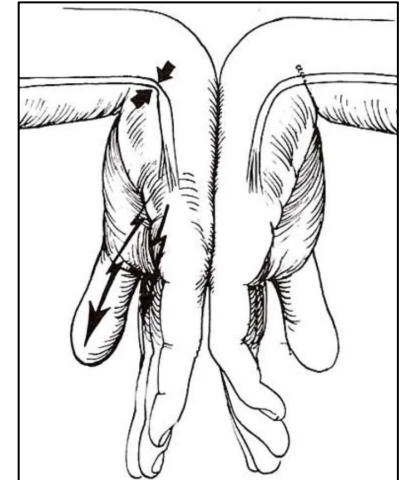
Ténosynovite : Test de Finkelstein

- Permet de mettre en évidence une ténosynovite des tendons du **long abducteur** et du **court extenseur du pouce** (ténosynovite de De Quervain)



Tunnel carpien : Test Phanel et Tinel

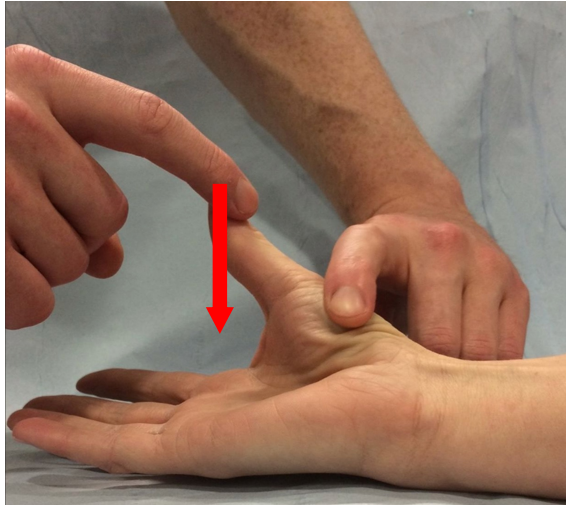
- Positif si déclenche les symptômes (paresthésie, douleurs neuropathiques) dans le territoire du **N. médian** (doigts I-III)



Poignet-main : Tests spécifiques

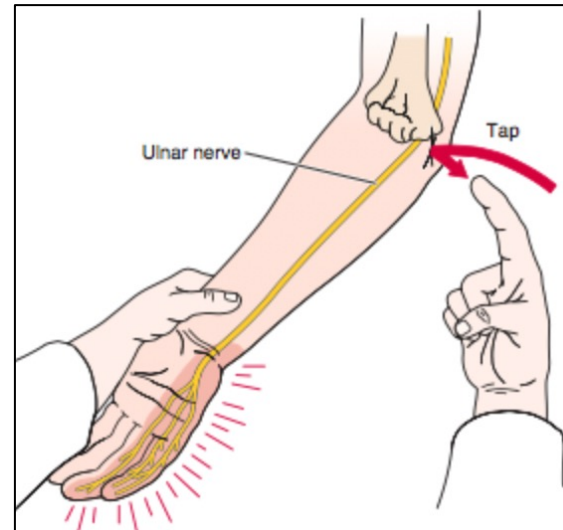
Tunnel carpien/cubital: Abduction pouce/auriculaire

- Test la force de l'abduction du pouce (muscle long extenseur et court abducteur du pouce, innervé par le **nerf médian**)
- Idem pour le **nerf ulnaire** (force dans l'abduction de l'auriculaire, tranche ulnaire sur la table et abduction contre la gravité et le poids de la main)



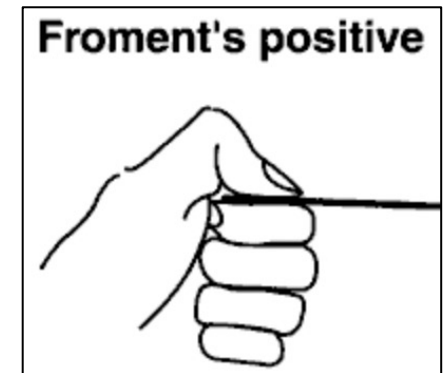
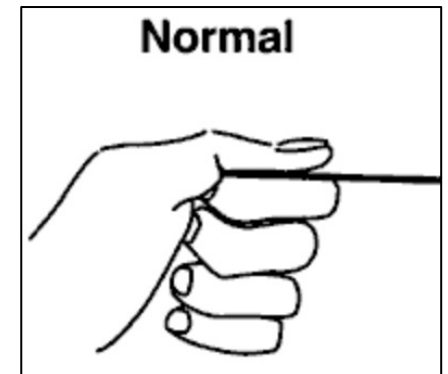
Tunnel cubital : Test de Tinel

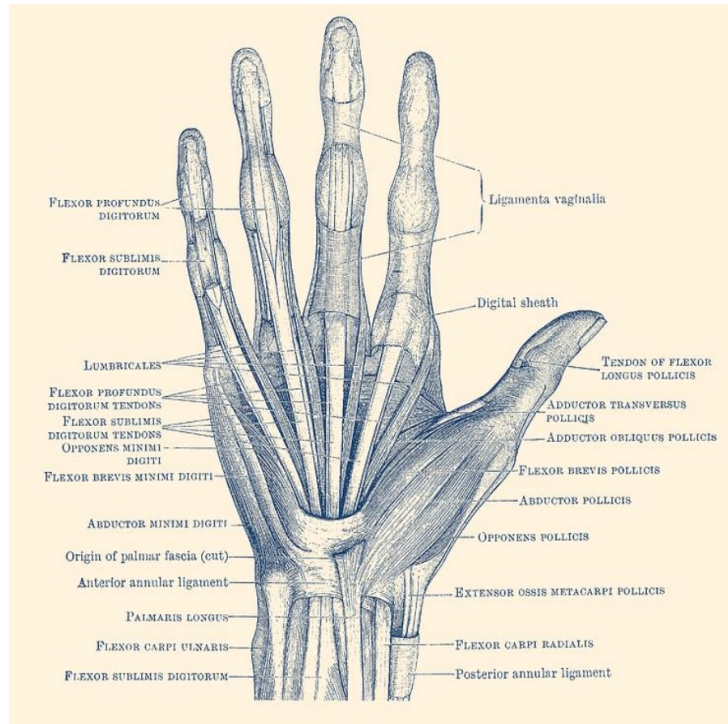
- Positif si déclenche les symptômes (paresthésie, douleurs neuropathiques) dans le territoire du **N. ulnaire** (doigts IV-V)



Tunnel cubital : Test de Froment

- Positif en cas d'hyperflexion compensatrice de l'interphalangienne du pouce (déficit en adduction sur atteinte du **Nerf ulnaire**)





Fracture du radius distal:

- **Définition :** Fracture fréquente du poignet, de distribution bimodale : 20-30 ans (traumatisme à haute énergie cinétique) et >65 ans (souvent simple chute/trauma mineur chez des femmes avec de l'ostéoporose).
- **Cliniques:** Douleurs, rougeur, diminution de l'amplitude articulaire et autres signes généraux de fractures (crépitation osseux, déformation...)
- **Diagnostic:** Radiographie (antéro-postérieur, oblique et latéral)
- **Traitement :** Conservateur pour les fractures fermées et stables.
Toujours chirurgical pour les fractures instables, intra-articulaire ou ouverte.

Fracture du scaphoïde :

- **Définition :** Fracture la plus fréquente des os du carpes. Touche le plus souvent le tiers intermédiaires de l'os scaphoïde. Le mécanisme est le plus souvent une chute en hyperextension et le pic d'incidence est entre 15-19 ans.
- **Cliniques:** Une douleur à palpation de la tabatière anatomique est un signe fortement évocateur.
- **Diagnostic:** Radiographie (AP, latéral, oblique). Attention, 25% des fractures du scaphoïde ne se voient pas sur une radiographie ! Rn cas de négativité considérer en imagerie en coupe.
- **Traitement :** Fracture non déplacée -> traitement conservateur,
Fracture déplacé >1 mm : prise en charge chirurgicale

Fracture du scaphoïde

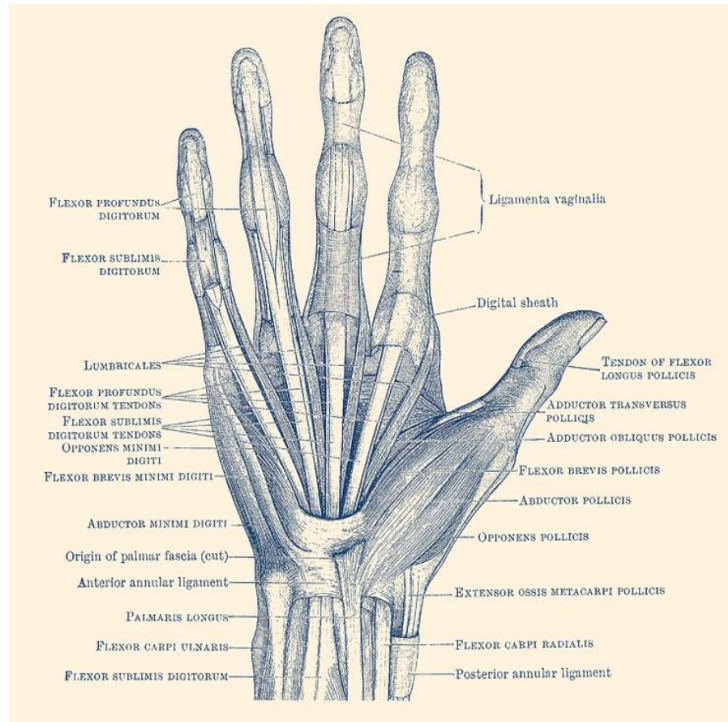


Fracture du scaphoïde



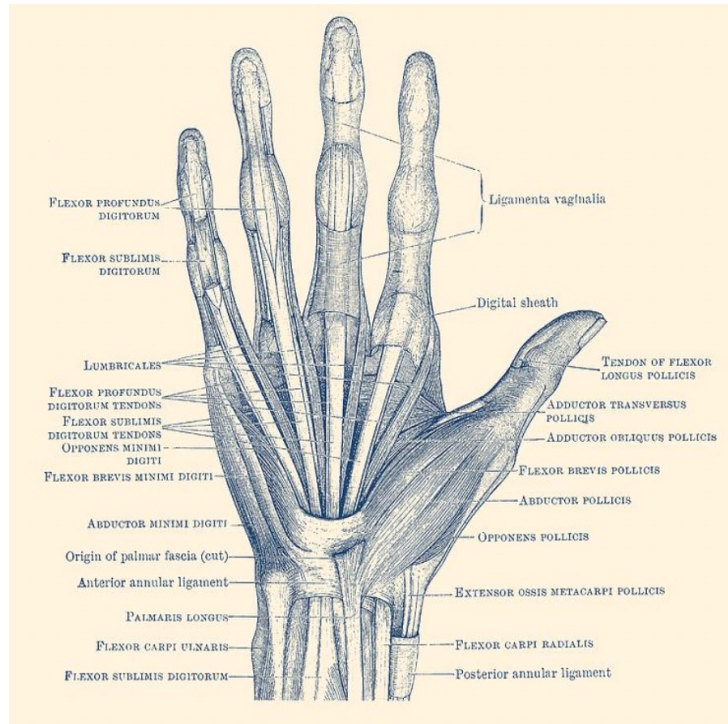
Fracture distale du radius





Ténosynovite :

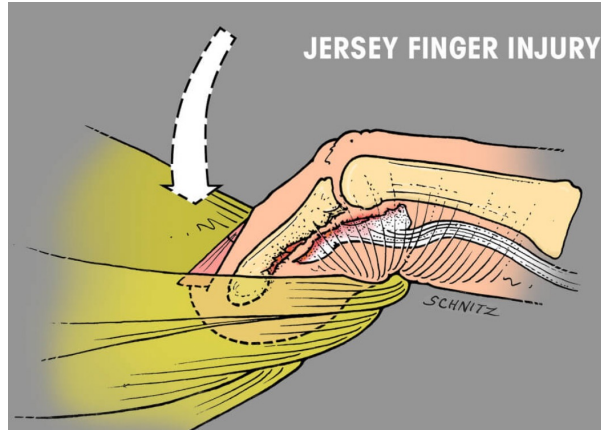
- **Définition :** Inflammation des tendons et de leur gaine synoviale, d'origine mécanique (fréquent : surutilisation), dysimmun (diabète, sarcoïdose, polyarthrite...) ou infectieux (Staphylocoque, Streptocoque, parfois *P. multocida*, *E. corrodens*, *P. aeruginosa*...). Touche le plus souvent les tendons du poignet et de la main.
- **Cliniques :** Douleurs à la mobilisation (surtout l'extension passive) et la palpation du tendon touché, œdème.
- **Diagnostic :** Le diagnostic est posé cliniquement. Des examens complémentaires peuvent-être nécessaire dans les cas auto-immun et infectieux.
- Entités particulières :
 - **Ténosynovite de De Quervain :** Touche les tendons des muscles **long abducteur** et **court extenseur du pouce**. Le plus souvent dans le cadre d'une surutilisation (texto, certains sportifs...), rarement sur polyarthrite rhumatoïde. Cliniquement : Positivité du **test de Finkelstein**.
 - **Doigts à ressaut :** Inflammation du tendon conduisant à la formation d'un nodule à la surface des tendons des muscles fléchisseurs des doigts. Le nodule peut empêcher le glissement du tendon dans sa poulie, conduisant à un blocage en flexion puis à un déblocage brusque (ressaut) lorsque l'obstacle est franchi.
- **Traitement :** Antibiotique IV (**Ceftriaxone**) et reprise chirurgicale en cas d'infection, autrement immobilisation par une attelle en combinaison avec des AINS. Si nécessaire injection de stéroïde. En dehors des cas infectieux, où l'opération est indispensable, on recourt à la chirurgie uniquement en dernier recours.



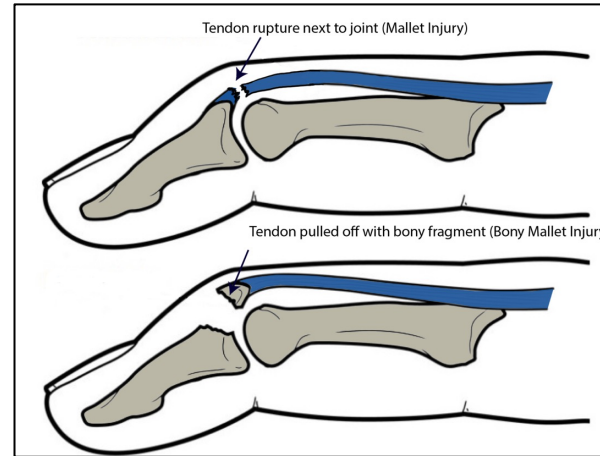
Lésion des doigts:

- **Entités :**
 - **Rugby/Jersey finger :** Lésions des tendons des fléchisseurs profonds des doigts, causé par une extension forcée.
Cliniquement : Rougeur, œdème et douleur au niveau de l'articulation interphalangienne distale (IPD). Perte de la flexion au niveau de l'IPD mais des articulations métacarpo-phalangienne (MCP) et IPP.
Traitement : Toujours chirurgical ! Réparation du tendon lésé.
 - **Doigt en maillet/marteau :** Lésions des tendons des extenseurs des doigts, causé par une flexion forcée des doigts. Attention, fréquemment associé à une lésion osseuse de la phalange distale.
Cliniquement : Incapacité à étendre le doigt avec **hyperflexion de l'IPD**
Traitement : En l'absence de fracture associée et d'un déficit en extension >45°, le traitement est conservateur. Autrement : reprise chirurgicale et réparation osseuse et tendineuse.
 - **Déformation en boutonnière:** Lésions de l'insertion du tendons des extenseurs des doigts au niveau son insertion sur la phalange intermédiaire, avec le tendon qui poursuit sa course jusqu'à la phalange distale. Multiples étiologies possibles : **polyarthrite rhumatoïde**, arthrose, traumatisme.
Cliniquement : **Hyperflexion de l'IPP** et **hyperextension de l'IPD**
Traitement : Conservateur ou chirurgical, en fonction de l'atteinte et de l'étiologie.
 - **Skier's thumb :** Lésion du ligament collatéral ulnaire (LCU) du pouce, causé par une hyperextension et une abduction forcée du pouce.
Cliniquement : Douleur, œdème et laxité de l'articulation métacarpo-phalangienne. Diminution de la force au moment de serrer quelque chose entre le pouce et l'index.
Traitement : Conservateur ou chirurgical, en fonction de l'atteinte et de l'étiologie

Rugby/Jersey finger



Doigts en maillet/marteau



Doigts en boutonnière

